

Вопрос: Может ли многоповторный тренинг быть полезным для сердечно-сосудистой системы?

Ответ: Да, он может приносить определенную пользу. Особенно если нагрузка настолько низкая, что ты ухитряешься дышать носом во время выполнения всего подхода. Однако, нужно учитывать пару моментов.

Многоповторный тренинг не является альтернативой кардио-тренировкам, а если ты раз в неделю делаешь присед на повторов это не освобождает тебя от необходимости делать низкоинтенсивное кардио. Ну и также многоповторка(когда речь идет не про насилие над пустым грифом) особенно в долгосрок в большей степени утомляет цнс и поэтому аккумулирует больше системной усталости и следовательно технически является субоптимальным тренингом. Это важно, это надо знать.

Вопрос: Что в тренировочной программе может вызывать наибольшую мышечную крепатуру на следующий день после тренировки? И как с этим бороться?

Ответ: Если про упражнения, то я бы сказал, что это скорее всего становая тяга, если тяга делается из дефицита, то может быть прям вообще “хорошо”. Если вопрос про сам дизайн тренировочной программы, то я бы сказал что скорее всего дело в чрезмерно большом тренировочном объеме. Да, в редких случаях может быть так, что проблема кроется и в высоких процентах/RPE, но большинство людей не настолько сильные, чтобы синглы в той же тяги “обездвижили” их на следующий день.

Бороться с этим естественно достаточно просто, нужно менеджерить нагрузку и не руководствоваться принципом бери больше, кидай дальше, это работает лишь непродолжительное время и лишь тогда, когда тебе <25(хотя есть исключения). Ну и естественно все то, что улучшает сон, по типу того магния/мелатонина несколько ускорит процесс, но не станет панацеей.

Вопрос: Есть ли смысл для достижения отказа в упражнении добиваться повторами в короткой амплитуде?

Ответ: В подавляющем большинстве случаев я бы сказал, что нет. Особенно выраженным это “нет” будет тогда, когда речь идет о тех участках амплитуды, где нет “растяжения” мышцы. Это а) аккумулирует доп усталость б) мало что дает с точки зрения гипертрофии в сравнении с теми же “lengthened partials”, которые предлагают делать Майло Вулф и Джеф Ниппард.

Я сторонник того, что для 95% людей отказ это тогда, когда не получается сделать следующее повторение в надлежащей технике. Дальше профитов уже не так чтобы много, а негативных последствий много.

Вопрос: Идея с уколом папаверина перед тренировкой рук непосредственно в тренируемую мышцу еще имеет право на жизнь в 2к24?

Ответ: Это конечно древние знания времен спортсвики, которыми обладали почитатели Зизза и прочие любители качать банки перед походами на дискотеку. Эта традиция ушла в небытие и я не могу сказать, что сильно расстроен.

По сути любой способ в краткосрочной перспективе апнуть производство простагландинов даст памп, который будет чуть ли не походить на отек, но это не особо поможет нарастить новые мышцы. В целом вообще вклад пампа в механизмы компенсаторных адаптаций всегда был несколько переоценен в качковском коммьюнити и даже несмотря на то, что он не нулевой, предпринимать ради него что-то кроме питья сиалиса/виагры/аргинина/цитруллина,- объективно не стоит того.

Вопрос: Если потреблять НПВС аккуратно после тяжелой тренировки по становой тяги и приседу, означает ли это, что эффективность этой тренировки снизится?

Ответ: Да, адаптационный стимул будет несколько ниже, но тебе не менее не будет сведен к нулю. Если у человека сильно разболелась спина или какой-то сустав, то коксибы или меклоксикам ему скорее всего не повредят.

Однако, если это происходит чаще чем раз в квартал(это не описка), я бы задался вопросом о том, насколько верно сконструирована тренировочная программа. Вообще в идеале прием НПВС должен сводиться к минимуму и да, если человеку нужно что-то кроме магна, пикамилаона или того же ибутаморена после тренировки, надо вспоминать ту цитата про «бери ношу по себе и бла бла бла». Дозирование нагрузок это ключ ко всему.

Вопрос: Правда ли, что метиленовый синий может поднимать артериальное давление за счет ингибирования NO?

Ответ: Он может это делать, если принимать в дозе от 5мг в сутки. Во всех меньших дозировках ингибирование NO не будет достаточным для того, чтобы повлиять на сердечно-сосудистую систему. Более того, в небольших дозах со временем давление может даже стать несколько ниже из-за роста числа и размера митохондрий. С МС очень четко прослеживается дозозависимость эффектов.

Вопрос: Дойдет ли эта рубрика до 1000 выпусков?

Ответ: Да, дойдет.